



Universidad de Ciencias Pedagógicas

“Enrique José Varona”

Facultad de Educación Infantil

Trabajo de Diploma

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Autora. Yalismary Chacón Durruthy

Tutora. Dr.C Maria Mercedes Arredondo Kassabb.

Profesora Titular

La Habana, Mayo del 2020

Dedicatoria

A mi madre Cora Ibis, por brindarme todo su amor incondicional, su apoyo, por estar conmigo en los momentos más difíciles, por su paciencia y por confiar en mí siempre.

A mi hermana Yusmara y su familia, por ser mi ejemplo a seguir, por apoyarme siempre a pesar no estén conmigo físicamente y dedicarme su amor infinito para poder realizar mi sueño de ser una profesional. Por ser como una segunda madre para mí, gracias mi hermana. Te amo.

A mi abuela Zaida, mis tías Inalvis y Marcia porque de una forma u otra estuvieron conmigo en estos 5 años apoyándome en todo lo que necesitaba para hoy lograr ser quien soy.

A mi padre porque a pesar de no estar presente en este mundo, estaría orgulloso de verme realizada como toda una profesional.

A mi tutora María Mercedes Arredondo por su apoyo y ayuda durante mi estadía en la Universidad de Ciencias Pedagógica Enrique José Varona.

A todo el profesorado que influyeron de manera positiva mi formación vocacional y hoy poder ser quien soy, por lo que estaré eternamente agradecida con ellos.

A todos muchas gracias de corazón

Resumen

Desde tiempos remotos se ha podido demostrar la importancia que tiene la comunidad y la familia en el desarrollo del lenguaje en los niños, y las consecuencias que les traería a ellos el mal empleo de este durante la etapa de adquisición. La Logopedia como ciencia tiene como objetivo principal la corrección y/o compensación de los trastornos de la comunicación no solo en el contexto educativo sino también desde la comunidad y parte de la atención logopédica.

Este trabajo se centra en la atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros de 0 a 5 años. Es por ello que su objetivo es diseñar un conjunto de actividades para prevenir y estimular el lenguaje en estos niños. Durante la investigación se emplearon distintos métodos del nivel teórico, empírico y matemático-estadístico, lo que permitió sustentar las problemáticas existente y dar una vía para su solución. Las actividades se enmarcan principalmente en el juego ya que esta es la etapa principal en la que se encuentra el niño, estas pueden realizarse en diferentes lugares ya sea en el punto logopédico, en el hogar o en otros lugares que brinda la comunidad. La valoración de los resultados sobre la propuesta diseñada demostró aptitud para su aplicación.

Palabras claves: corrección, compensación, atención logopédica, prevención

Summary

Since ancient times it has been possible to demonstrate the importance of the community and the family in the development of language in children, and the consequences that would be brought to them by the misuse of this during the acquisition stage. Speech therapy as a science has as its main objective the correction and / or compensation of communication disorders not only in the educational context but also from the community and part of the logopedic care. This work focuses on community logopedic care for the prevention of language disorders in preterm children from 0 to 5 years old. That is why its goal is to design a set of activities to prevent and stimulate language in these children. During the investigation different methods of the theoretical, empirical and mathematical-statistical level were used, which allowed to sustain the existent problems and to give a way for their solution. The activities are mainly framed in the game as this is the main stage in which the child is, these can be done in different places either in the speech therapy point, in the home or in other places provided by the community. The evaluation of the results on the designed proposal showed aptitude for its application.

Keywords: correction, compensation, logopedic care, prevention

ÍNDICE**PÁG.**

INTRODUCCIÓN	1
DESARROLLO	
CAPÍTULO I. Referentes teóricos y metodológico que sustenta el desarrollo de la atención logopédica comunitaria en niños prematuros con trastornos en el lenguaje.	8
1.1 La atención logopédica comunitaria	8
1.2 La prevención de los trastornos del lenguaje	12
1.3 La prematuridad. Un hecho de salud contextualizado	17
CAPÍTULO II. Propuesta de un conjunto de actividades para la atención logopédica comunitaria en la prevención de los trastornos del lenguaje	21
2.1 Operacionalización de la variable	21
2.2 Caracterización del estado inicial de la atención logopédica comunitaria en niños prematuros con trastornos en el lenguaje.	22
2.3 Presentación de la propuesta.	26
2.3.1 Fundamentación de la propuesta	27
2.3.2 Estructura y funcionamiento de las actividades	28
2.4. Valoración de la propuesta	30
2.4.1 Implementación de la propuesta	31
Conclusiones	32
RECOMENDACIONES	33
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

Introducción

El lenguaje surgió como una necesidad que tuvo el hombre para comunicarse en el medio social que lo rodea, su desarrollo y enriquecimiento depende de la capacidad que tiene el ser humano para analizar, sintetizar, extraer y generalizar el proceso de su interrelación activa con fenómenos y objetos, por lo que cada uno de sus palabras constituyen un acto verbal del pensamiento. Este no aparece desde el nacimiento del hombre sino se va desarrollando a través de su interiorización y exteriorización.

El lenguaje es la actividad básica en el desarrollo integral y se produce de forma acelerada en la edad temprana. El periodo prelingüístico es observado en los primeros tiempos de la vida posnatal, limitado a la expresión corporal y algunos sonidos, experimenta un proceso direccionado al dominio de signos lingüísticos, para expresar deseos, ideas, relacionarse y afirmar la identidad, y pasa entonces del lenguaje corporal a complementar el oral. Este es un elemento importante en la vida ya que permite ampliar las posibilidades de la comprensión de entorno y la comunicación que no es más es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Su objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea.

El niño aprende el lenguaje mediante un proceso que no se le torna consciente; lo construye de manera natural y fisiológicamente, interactuando cotidianamente con los objetos y los otros sujetos de su entorno cultural. Ellos en sus primeros años de vida están llenos de hitos cruciales y de hazañas decisivas, pero tal vez el acontecimiento singular más celebrado es la producción de las primeras palabras. Su desarrollo integral se lleva a cabo sobre la base de la experiencia histórica social de la humanidad que solo puede transmitirse mediante el lenguaje.

Diferentes autores Bell R. (1995), Figueredo. E (1996), Figueredo (2000), R. López Machín (2000), Pérez (2002), Betancourt y González (2005), Chernousova (2008) y Peña (2011) coinciden en destacar que el lenguaje constituye la envoltura

material del pensamiento, es el principal medio para la comunicación humana que realiza a través de un sistema funcional complejo, en el que se emplean símbolos específicos principalmente verbales y orales y recalcan en la importancia que tiene prevenir los trastornos que pueden existir en él.

Vigotsky en su aporte destaca el estudio filogenético y ontogenético del pensamiento y el lenguaje, la unidad e independencia relativa, el proceso de adquisición y aprendizaje de las palabras, el concepto de unidad-significado, lo que supera la simple relación entre estímulos verbales y objetos. Los estudios acerca de la génesis del lenguaje y las etapas de transición entre este y las formas externas y otros aportes, constituyen los pilares más importantes para el desarrollo de la personalidad en los niños y su relación en la actividad de la edad temprana.

Es por tanto interesante conocer el embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana para el futuro desarrollo del lenguaje, que tiene una duración normal de 40 semanas, o sea, 280 días a partir del primer día de la última menstruación. Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que esta cifra no es exacta, muchas embarazadas tiene su parto de una a tres semanas antes o después de esta edad gestacional y el recién nacido tiene todas las características de un niño nacido a las cuarenta semanas, a partir de la curva de desarrollo cuando se registran parámetros por debajo de la vida gestacional normal se es proclive a una prematuridad.

Cuba en la actualidad registra la tasa de prematuridad como una de las más bajas del mundo con un índice de 6.4 por cada 100 nacimientos hasta el momento. Estos niños que reciben el nombre de prematuros, por lo general son de causa multifactorial y es el parto ocurrido antes de 37 semanas de gestación, en oposición a la mayoría de los embarazos que duran más de 37 semanas. El nacimiento prematuro ocurre entre 6-12% de los nacimientos en la mayoría de los países y mientras más corto sea el período del embarazo, más alto es el riesgo de las complicaciones.

Según expresa el MSc. E. Olivera en el año 2001, en los últimos años los investigadores dividen a los destinatarios de la estimulación temprana en tres

grupos fundamentales. El segundo está integrado por niños en situación de riesgo biológico por prematuridad, por bajo peso para la edad gestacional, por sufrimiento perinatal y por hipoxia.

Como antecedentes de los estudios realizados acerca de la prematuridad abordado por investigadores en el área internacional y nacional, encontramos aseveraciones en sus planteamientos como: Rigol Ricardo, O (1989 – 2004), Volpe, (2001). Pilar Álvarez, M (2002), González, (2005), David van Essen (2006), González, F (2012), Inge Van Noortvan der Spek. Centro Médico Erasmus en Rotterdam, Holanda (2014) entre otros los cuales coinciden en que los niños prematuros experimentarían un retraso en la comunicación y el lenguaje, afectando su desarrollo integral.

Cuba como respuesta al trabajo con estos niños se basa en los presupuestos de la política educativa y de salud. Tiene la perspectiva de brindar una educación de calidad y equidad que dé respuesta a las necesidades y demandas de los niños desde la primera infancia para prevenir los trastornos de la comunicación y el lenguaje o para atenuar en los casos más complejos la discapacidad comunicativa: entre ellos la prematuridad como prevención desde edades temprana utilizando como vías fundamentales la atención logopédica comunitaria con una concepción pedagógica del proceso. Esta no es más que el sistema de acciones o tareas basadas en el trabajo y el diagnóstico logopédico que debe realizar el logopeda para la investigación, atención, evaluación y prevención de los trastornos de la comunicación en aquellos niños con alto riesgo de prematuridad en la comunidad.

En tanto la atención logopédica comunitaria es un término tratado como una alternativa por diferentes autores noveles en este campo entre ellos se destacan: Arredondo, Kassabb. M.M. (2016), Gómez Salas. L. (2016), Hernández. Rodríguez, A. (2017), Castillo, Álvarez. R. (2018), por lo que plantean la posibilidad de involucrar el contexto comunitario como lugar potenciador del desarrollo desde la primera infancia en niños prematuros.

Por todo lo expuesto anteriormente a través de los estudios realizados se evidencia que aún es necesario trabajar más sobre dicha atención logopédica comunitaria. La experiencia en la práctica educativa, el estudio de la prematuridad en el contexto comunitario (2017- 2018), la observación a niños con alto riesgo en su desarrollo conjuntamente con el médico de la familia permitieron identificar la siguiente **situación problemática**:

- La falta de preparación de la familia para contribuir al desarrollo del lenguaje en niños prematuros.
- Insuficiente atención logopédica a niños prematuros con trastornos en el lenguaje.

Lo cual permitió identificar como problema científico: ¿Cómo contribuir a la atención logopédica comunitaria en la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros del reparto Versalles- Coronela del municipio La Lisa?

Con el propósito de solucionar el problema científico se determina como objetivo de la investigación: Proponer actividades profilácticas para la atención logopédica comunitaria en la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros del reparto Versalles- Coronela, del municipio La Lisa.

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto y brindar solución al problema científico identificado se plantean las siguientes preguntas científicas:

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros?
2. ¿Cuál es el estado inicial de la atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos en el lenguaje en niños prematuros del reparto Versalles – Coronela del municipio La Lisa?
3. ¿Qué estructura y contenido debe poseer las actividades profilácticas para la atención comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros del reparto Versalles- Coronela, del municipio La Lisa?
4. ¿Qué resultados se obtienen con la aplicación de actividades profilácticas para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros del reparto Versalles- Coronela, del municipio La Lisa?

En correspondencia se diseñaron las siguientes tareas científicas.

1. Análisis de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros.
2. Caracterización del estado inicial de la atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje a niños prematuros del reparto Versalles – Coronela del municipio La Lisa.
3. Diseño de actividades profilácticas para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros del reparto Versalles – Coronela del municipio La Lisa.
4. Valoración de los resultados que se obtienen con la aplicación de actividades profilácticas para la prevención de los trastornos del lenguaje a niños prematuros del Reparto Versalles – Coronela del municipio La Lisa por criterios de especialistas y usuarios.

Esta investigación se sustenta en el método dialectico – materialista como método general de las ciencias al permitir apreciar el fenómeno estudiado en su objetividad y relevar sus causas.

Métodos del nivel teóricos

Analítico y sintético: Permite durante todo el proceso de investigación el estudio de las concepciones teóricas acerca de la atención logopédica comunitaria para niños prematuros.

Inductivo- deductivo: Permite deducir como relacionar en el plano de lo teórico y práctico, referente a la prematuridad y su influencia en el desarrollo de las habilidades comunicativas y del lenguaje desde la atención logopédica comunitaria

Sistémico estructural: Permite la determinación de la estructura de las actividades profilácticas que se propone para el trabajo con niños prematuros durante la atención logopédica comunitaria.

Modelación: Permite utilizar actividades logopédica para el desarrollo de la atención logopédica comunitaria.

Métodos del nivel empírico

Observación: permite observar aspectos de la exploración logopédica y los modos de actuación del niño y la familia en cuanto al lenguaje. Este método se apoya en una guía de observación a actividades realizadas en el municipio La Lisa.

Entrevista: permite conocer aspectos sobre el desarrollo del lenguaje en niños prematuros en el municipio La Lisa.

Encuesta: se les realiza a las familias con el objetivo de valorar los conocimientos que poseen en cuanto al lenguaje sobre sus hijos prematuros en el municipio La Lisa.

Exploración logopédica: se realiza con el objetivo de evaluar los diferentes aspectos del desarrollo del lenguaje en el grupo de estudio.

Análisis documental: Este método fue empleado para efectuar una revisión bibliográfica, lo que permitió realizar una fundamentación teórica del problema científico a partir de la información actualizada referida en documentos legales, jurídicos y bibliográficos.

Producto de la actividad: se utiliza con el objetivo de recoger las informaciones necesarias sobre el desarrollo del niño prematuro en el municipio La Lisa.

Consulta a especialistas y usuarios: permite si las actividades realizadas son viables o no.

Los **métodos matemático - estadístico** de carácter descriptivo, permiten el análisis de los datos obtenidos producto de los instrumentos aplicados y establecer generalizaciones a partir de ellos, se recogerán en tablas la información resultante, declarando frecuencia absoluta y porcentual.

Grupo de estudio: Se seleccionó en correspondencia con los fines de la investigación:

Grupo A: 10 niños prematuros que oscilan entre 0 y 5 años y 10 madres.

Grupo B: 4 maestros logopedas y 4 médicos de familia con más de 5 años de experiencia.

Grupo C: 10 especialistas que valoraron de forma preliminar la propuesta

Actualidad: La investigación revela pesquisar a niños prematuros y valorar la influencia de esta condición en el desarrollo del lenguaje desde la primera infancia. Es una temática actual ya que se da con regularidad en el contexto comunitario y se ha socializado en coloquios relacionado con el tema abordado, en diferentes eventos y talleres científicos. Responde a una línea de investigación del Proyecto institucional "Buenas prácticas socioeducativas comunitarias para el desarrollo del lenguaje en niños, jóvenes y adulto" de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona" que dirige la Dr. C. María Mercedes Arredondo Kassabb y a la cátedra honorífica Ricardo Cabanas Comas y al grupo científico Comunicación y Lenguaje.

La investigación consta de: introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que completan los estudios realizados. En la introducción, aparece el diseño teórico metodológico que guía la lógica investigativa, se señala la actualidad científica, así como la importancia social del tema y su pertinencia. En el desarrollo se abordan dos capítulos: Capítulo 1: Establece los referentes teórico-metodológicos relacionados con los núcleos teóricos. El Capítulo II: Incluye la operacionalización de la variable de la investigación, su valoración por especialistas y usuarios, se precisa el diagnóstico del estado inicial a partir de la aplicación de los instrumentos, así como las actividades `profilácticas para dar solución al problema investigado y los resultados que se obtienen con su aplicación. Se señalan las referencias bibliográficas, bibliografía, conclusiones, recomendaciones, y 7 anexos.

Capítulo I. Referentes teóricos y metodológico que sustenta el desarrollo de la atención logopédica comunitaria en niños prematuros con trastornos en el lenguaje.

En el capítulo se tratan los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con la atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros, se enfatiza en esta población por las características que ellos presentan.

1.1 La atención logopédica comunitaria. Particularidades

La concepción de atención logopédica se acoge en la Psicología y la Pedagogía y otras ciencias médicas y pedagógicas, a partir de la influencia de los postulados de la escuela histórico cultural de Vigotsky y sus seguidores, (1982), en particular con la Zona de Desarrollo Próximo; indica la posibilidad que tiene el niño ayudado por el adulto o en colaboración con este, para realizar aquello que él no puede hacer por sí mismo y fundamenta el vínculo entre educación y desarrollo al poner énfasis en la importancia de los "otros" y lo vivencial. En este sentido adquiere gran significación en la atención logopédica, vista esta como un proceso esencialmente de interacción entre sujetos.

La atención logopédica consiste según Pérez, E. (2002) en un proceso de alternativas pedagógicas que se insertan en la dirección del aprendizaje, al estructurar los niveles de prevención para las personas con necesidades educativas en la comunicación verbal. Tiene como rasgos principales su carácter procesal, sistémico, de ofrecer opciones pedagógicas es flexible, dinámico, abierto ya que permite la atención temprana a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, además de que parte de los agentes educativos por excelencia: la familia y la comunidad. Esta permite la orientación a especialistas del área de la salud, la educación, promotores culturales, a ejecutores entre otros para estimular su desarrollo.

Para Morales M. (2004), la atención logopédica se refiere al sistema de acciones o tareas basadas en el diagnóstico logopédico que tiene un carácter psicopedagógico y están dirigidas a la prevención, atención, evaluación e

investigación científica de la comunicación humana y sus trastornos. Esta es una definición de amplio alcance que precisa los elementos esenciales de la atención logopédica, sin embargo no revela su carácter multifactorial en el proceso educativo.

En este mismo año realiza un estudio acerca de la atención logopédica e identifica tres tendencias fundamentales, la clínico-terapéutica, la psicopedagógica y la preventiva; en dicha investigación se fundamenta el enfoque preventivo desde el protagonismo del logopeda, no sólo para intervenir en el lenguaje y la comunicación en casos de alteraciones sino en la labor anticipada con todos los escolares para prevenir dichas alteraciones; lo que se evidencia en los principios propuestos para la intervención logopédica que requieren los niños prematuros para potenciar el lenguaje oral, y específicamente en el de flexibilidad metodológica para su atención oportuna.

Por lo que Chernousova, L. (2008) asume la posición de Pérez (2002), y resume que la atención logopédica comprende los procesos de prevención, diagnóstico y estimulación, pero adquieren una significación diferente a la que tienen en la concepción como proceso de tratamiento logopédico. Se acentúa el carácter pedagógico de la atención, con el logopeda como asesor y la participación de todos los educadores, los escolares la familia y la comunidad.

La especialista y profesora Fernández G. (2008), analiza el modelo de atención logopédica en Cuba, que incluye el contexto educativo y el de salud; precisa los diferentes momentos por los que atraviesa; los sustentos teóricos y las principales categorías de esta ciencia. Al referirse a la labor del logopeda, enfatiza en la atención logopédica y plantea que todas las acciones de la misma deben ir encaminadas a prevenir las posibles insuficiencias del desarrollo y a estimular al máximo las potencialidades de los niños.

Años después Fernández G. (2012), en su libro *Logopedia I* define atención logopédica como *el “proceso especializado dirigido por el logopeda, de carácter integral, muti e interdisciplinario que se desarrolla preferentemente, en los diferentes contextos educativos, preescolares y escolares, la familia y la comunidad. Se inicia*

con el diagnóstico y utiliza como vía el método integral de atención logopédica, las ayudas, recursos y apoyo que propician la prevención, la estimulación y desarrollo del lenguaje, la corrección y la compensación de los trastornos del lenguaje y de la comunicación, el desarrollo multilateral del niño, la evaluación y seguimiento de los resultados.”¹

El objetivo de esta atención es prevenir, corregir y compensar los trastornos del lenguaje y desarrollar al máximo de las posibilidades las habilidades comunicativas de las personas independientemente, del tipo de lenguaje, lengua o sistema que utilice para lograr una comunicación de calidad, que propicie el proceso de inclusión social. Se tiene en cuenta además, la atención de las educadoras y maestros que está dirigida a transmitir seguridad y apoyo al niño en las actividades que se desarrollan en la institución escolar, dedicar especial atención en las clases de desarrollo de la lengua materna y lectura de manera que se enriquezca el desarrollo del lenguaje y la comunicación, no obstante se ignora la participación de agencia y agentes educativos y sociales por lo que interactúa desde su nacimiento el niño, es decir la comunidad, el barrio, sus vecinos, amiguitos, familiares, que potencian su comunicación.

En el binomio de agencias educativas está la escuela y la comunidad por lo que la atención comunitaria junto con la orientación a la familia se desarrolla y está encaminada desde programas como el Programa Social Nacional “Educa a Tu Hijo”, la visita al hogar, el trabajo de las instituciones culturales de la comunidad y los medios de difusión masiva al servicio de la educación familiar y comunitaria, entre otros.

Esta definición de atención logopédica se trabaja en todas las instituciones educativas de cualquier enseñanza del país y se preparan a los futuros profesionales de esta ciencia, las necesidades del país y las demandas de la sociedad han obligado a expandir esta atención a otros contextos, aprovechando sus recursos, estimulando sus potencialidades y brindando la suficiente preparación para

¹ Fernández. G: Logopedia I, Editorial pueblo y educación, p.46

asegurar el máximo desarrollo integral posible de cada uno de los niños/as, jóvenes y adultos.

La Dr.C Gudelia Fernández en su artículo testimonial sobre su práctica pre profesional en la extinta URSS hace un profundo análisis sobre la atención logopédica que se realizaba en las comunidades y plantea algunas ventajas y desventajas que en aquel momento. A su criterio la atención logopédica comunitaria es una parte de la Logopedia que se dedica a la atención logopédica integral, que involucra a los agentes educativos en función de atender el lenguaje y sus trastornos respetando la diversidad cultural de sus miembros. La autora destaca el papel que ejercen en las comunidades y los agentes educativos.

Para ayudar a establecer la atención logopédica en el espacio comunitario se debe tener en cuenta *la utilización de los recursos con que se cuenta, de la comprensión de sus problemas, establecer acción a través de los grupos para mejorar el entorno social, que sean sentidas como propias con influencias colectivas.*² Esta aseveración permite determinar cómo se debe proceder para trabajar la conciencia de necesidad y la posibilidad de mejorar en la comunicación y el lenguaje.

Es por ello que la Dr.C Arredondo, M.M (2015) considera que atención logopédica comunitaria se refiere a *“enfoque preventivo de inclusión social para la atención logopédica, en la diversidad de niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos para un óptimo desempeño de las habilidades comunicativas y sociales en un entorno determinado con carácter intersectorial”*³. Este concepto es el más actualizado puesto que revela la importancia que se le es otorgado esta atención logopédica en su carácter preventivo en el contexto social. Esta definición tiene gran importancia porque se le otorga gran relevancia al marcado perfil preventivo que adquiere la atención logopédica comunitaria teniendo en cuenta que el contexto comunitario

²Raya Diéguez. E.: Fundamentos de trabajo social comunitario. Editorial Alianza S.A. 2008. Madrid. España. Pág. 45. ISBN 84-206-4726-8

³Arredondo Kassabb. MM.: Aplicación de buenas prácticas socioeducativa para la atención logopédica en niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la comunidad. Perfil Proyecto 2015.

propicia mayor acceso a la población de cualquier edad y con cualquier grado de escolaridad direccionado su accionar hacia la comunidad, en, con y para la comunidad.

La Lic. Gómez Salas. L. (2017) toma en cuenta la definición dada por Dr.C Arredondo, MM (2015) y define la atención logopédica comunitaria como el *proceso pedagógico dirigido por el logopeda que se desarrolla en la comunidad; encaminado a favorecer la prevención, la estimulación, el desarrollo del lenguaje y la corrección y compensación de los trastornos de la comunicación, a partir del respeto a la diversidad sociocultural de sus miembros; con la indispensable gestión y apoyo de todos los agentes educativos comunitarios y la labor del maestro logopeda*".⁴

Asumiendo el concepto dado por Arredondo, MM (2015) se ajusta al objeto investigado se operacionalizó el término atención logopédica comunitaria y se concibe como: *el proceso especializado que se concreta en los diferentes contextos educativos donde se previenen, corrigen y/o compensan en condiciones de cooperación, las alteraciones del lenguaje, en un enfoque preventivo de inclusión social para la atención logopédica, en la diversidad de niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos para un óptimo desempeño de las habilidades comunicativas y sociales en un entorno determinado con carácter intersectorial*".⁵

La atención logopédica comunitaria es una forma de brindar atención logopédica desde otro contexto. Con mayor sistematicidad y difusión en la masa poblacional. Además permite utilizar todas las potencialidades de las comunidades, los recursos de estas y las particularidades de sus agentes educativos comunitarios para favorecer la comunicación en las localidades, prevenir trastornos logopédicos y orientar a las familias sobre el manejo y atención de sus hijos, adolescentes, jóvenes y adultos.

1.2 La prevención de los trastornos del lenguaje

⁴Gómez Salas. L. (2017): Operalización del constructo según el objeto a estudiar. Tesis de Diploma 2016.

⁵Arredondo, MM: Art. La atención logopédica comunitaria. El Punto Logopédico. Revista Google Académico. (2015). Cuba. Pág. 3

El lenguaje va dirigido al niño por los miembros de su entorno inmediato, lo que hace posible que su adquisición sea importante. Estos componentes no son suficientes para asegurar el normal desarrollo del lenguaje. Este es un aprendizaje natural que aparece y se desarrolla gracias a la interacción en un contexto determinado es por eso que se dice que “*el niño aprende hablar porque hablan con él*”.⁶ El lenguaje también puede sufrir deterioros en su desarrollo y no siempre se deben a una agresión neurológica, traumatismo, trastornos orgánicos, sino que derivan de una deficiente adquisición de modelos ausentes o inadecuados, falta de interacción verbal provocando que puedan aparecer en el niño diferentes trastornos en el lenguaje. Es por ello que para evitar que aparezcan estos trastornos se realizan diferentes actividades para prevenirlos.

Es por ello que la prevención al decir de los investigadores...*es detección precoz de las posibles dificultades y es el desarrollo de programas de prevención adecuada a las edades tempranas.*⁷ *Es la acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo.*⁸

El término prevención es una categoría que al ponerse en práctica adopta objetivos estratégicos específicos. En esencia, como concepto se refiere a evitar o disminuir las consecuencias del efecto de un factor causal conocido total o parcialmente. Lantigua, A. (2003)

Prevención significa además, prepararse y disponer de lo necesario, con anticipación, para alcanzar un fin; es actuar para que un problema no aparezca, es adelantársele de forma creativa. Travieso, Eulalia, (2008)

La prevención se concibe en la actualidad como un abordaje que incluye todas las disciplinas y los diferentes sectores de la sociedad. El fin está claro, debe haber una articulación del conocimiento interdisciplinario. Ahora el enfoque más que dirigido a factores de riesgo se enfatiza en el fortalecimiento de factores de desarrollo en un proyecto de vida.

⁶ Tought, 1987, pág. 23

⁷ Dr. Gómez López S. La prevención de dificultades del lenguaje oral en el marco escolar (2015)

⁸ Diccionario de la Real Academia Española.

La prevención no es la tarea de profesionales que respondan a un determinado perfil, sino que involucra a un grupo interdisciplinario de profesionales y agentes comunitarios.

En este sentido, la atención logopédica comunitaria tiene un enfoque preventivo de inclusión social para la atención logopédica, en la diversidad de niños, adolescentes, jóvenes y adultos para un óptimo desempeño de las habilidades comunicativas y sociales en un entorno determinado con carácter intersectorial.⁹Arredondo, M, M (2015)

La prevención, debe verse como un hecho humano, fundamentar sus acciones en la persona y la sociedad, más que en las sustancias, se debe ir a la raíz del problema, implica revisar el rol de los procesos socializadores de la familia, la escuela y la comunidad donde se ha producido un vacío. Esta es un proceso educativo que pone su acento en la instrumentación para la vida.

Es por ello que se debe dar una visión holística al hecho de que la prevención va dirigida, además, a los trastornos del lenguaje que revela que no es más que todo el conjunto de actuaciones que se realizan con el fin de prevenir, disminuir o suprimir la incidencia dentro de una determinada patología, alteración, dificultad o problema.

Así como en otras áreas, en los trastornos del lenguaje podremos diseñar estrategias preventivas a varios niveles, partiendo y adaptando la tradicional formulación de Caplan (1964), quien distingue tres ámbitos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Todo proceso preventivo debe partir de una evaluación inicial temprana, sobre todo de los considerados grupos de riesgo, para posibilitar una intervención precoz sobre las diferentes problemáticas.

La prevención primaria se dirige a la población general para evitar la aparición de problemas lingüísticos a partir de la reducción o de la eliminación de los factores o causas determinantes, que se asocian con la futura aparición del problema. Trata, de impedir la aparición de los trastornos lingüísticos a partir de su detección temprana.

⁹Arredondo, M, M: Atención logopédica comunitaria. Artículo Revista REDIPE ISBN: 978-1-945570-14-8. Cuba- Colombia. 2015. Pag.6

Los programas de prevención, en este caso, deben realizarse sobre todo en el marco escolar, formulando unos objetivos y estrategias que se incluyan en el diseño de los proyectos de centro. Según Ornitz (1986), «prevención primaria es la prevención de la ocurrencia, o al menos de la expresión, del trastorno».

La prevención secundaria se centra en detener el avance del trastorno que fue detectado a partir de un diagnóstico precoz, realizado en todas aquellas poblaciones que forman parte de grupos de riesgo, por estar relacionados con los diferentes factores que definen las dificultades en el lenguaje. Así, dentro de las distintas etapas curriculares –infantil, primaria, secundaria-, como señala Mayor (1994), se darán respuesta a las necesidades del niño que en algún momento de su instrucción presente dificultades en el desarrollo y adquisición del lenguaje.

Siguiendo a Serón y Aguilar (1992), son seis los principales factores de riesgo que más inciden en la aparición de trastornos, estos son: genéticos, diabetes, drogas y narcóticos, prenatales, postnatales y ambientales. Los cinco primeros hacen referencia a factores orgánicos, con importantes alteraciones biofisiológicas. Frente a éstos, los factores ambientales, que señalan a la familia y a la escuela como los núcleos centrales de las deficiencias lingüísticas.

La prevención terciaria, por último, se dirige a reducir o impedir la formación de consecuencias del trastorno en personas que ya muestran signos evidentes del mismo, con el fin de aminorar los posibles efectos o bien de prevenir nuevas apariciones de problemas. Se habla, sobre todo, de niños que sufrieron de alteraciones prenatales, perinatales o postnatales, quienes van a precisar de unos servicios de intervención precoz para su integración. Así, resultan de capital importancia los primeros años de vida para comenzar con la intervención (Lambert, Rondal y Serón, 1991) que, sin evitar el cuadro de su patología, puede lograr que cada niño funcione dentro de su potencial lingüístico máximo (Ingalls, 1982).

La prevención de las diferentes dificultades lingüísticas está estrechamente relacionada con dos procesos primordiales en las dificultades del lenguaje: por un lado, con el proceso evaluativo y, por otro, con la precocidad de la intervención derivada de esta exploración previa, sobre todo para los primeros años de vida.

La prevención debe seguir lo planteado por Vigotski respecto a que el período de mayor plasticidad del sistema nervioso y más sensitivo para el desarrollo general del niño es el comprendido entre 0 y 5 años. Al reflexionar sobre estas palabras y en relación con el binomio plasticidad-vulnerabilidad y el contenido de la estimulación temprana, es necesario tener en cuenta las categorías sociales, biológicas y psicológicas en el que el niño se ha desarrollado.

Para llevar a cabo programas preventivos se debe, inicialmente, partir del estudio de aquellos grupos de riesgo que se configuran dentro del panorama de los actuales criterios clasificatorios de las dificultades lingüísticas,

La prevención de estas alteraciones tiene que ver con la preparación previa del embarazo, durante y después del mismo. Serían indicados los programas de educación para la salud, en los cuales se señalan en las condiciones higiénicas, dieta y controles médicos durante estos períodos. Asimismo, en el caso de personas que presentan una discapacidad cognitiva que en su nacimiento se presuponga va a sufrir de alteraciones lingüísticas, resultará eficaz su incorporación a programas de estimulación precoz, en los que se potencie al máximo las capacidades comunicativas de estos sujetos, con el fin de evitar mayores e indeseables consecuencias futuras.

En los estudio aplicados en la actualidad, todas las acciones deben ir encaminadas a estimular al máximo las potencialidades de los niños, a prevenir los efectos de las condiciones de vida y educación cuando estas no están en correspondencia con las necesidades de los niños, a minimizar las posibles insuficiencias que en el desarrollo estas condiciones provocan; por tanto, el trabajo se encamina a estimular al máximo las potencialidades de cada uno de los niños, a que sean atendidos tempranamente, de manera que se pueda estimular el desarrollo mediante la orientación oportuna y especializada a la familia; lo que incluye el desarrollo integral del niño y su socialización e integración plena a la sociedad.

Al referirse al concepto potenciar el desarrollo del lenguaje, se hace en términos de impulsar y lograr el desarrollo óptimo de la comunicación y el lenguaje posible en los niños prematuros, de habilidades comunicativas, de manera que coincidan

las influencias educativas para el logro de un desarrollo máximo de la comunicación y el lenguaje.

Es por ello el marcado proceso de prevención de niños que como antecedentes han tenido prematuridad para desde su nacimiento, potenciar habilidades lingüísticas con intencionalidad hacia la elevación de calidad de su vida futura.

1.3 La prematuridad. Un hecho de salud contextualizado

Dado las demandas del desarrollo prenatal, nuestro país desarrolla un programa PAMI que permite una atención oportuna y preventiva para alcanzar estadios superiores en las proles como garantía gubernamental. Cuando aparecen dificultades durante el embarazo puede la madre estar en riesgo de tener un parto prematuro.

Es por ello que la prematuridad puede estar relacionada con complicaciones propias del embarazo, toxemia, sangramiento, embarazos múltiples, también puede estar asociado a factores socioeconómicos, nutricionales, genéticos y según algunos autores aseguran que puede llegar a ser hereditarios. Los bebés que nacen en forma prematura tienen un alto riesgo de muerte en sus primeros años de vida. *La prematuridad es la cualidad o condición que se utiliza para nombrar aquellos niños que nacen antes de terminar la gestación.*¹⁰ *Los recién nacidos prematuros son aquellos niños que nacen antes de completar la semana 37 de su embarazo.*¹¹

Existe también un alto riesgo de desarrollar serios problemas de salud como *patologías respiratorias, neurológicas, cardiovasculares, oftalmológicas, gastrointestinales, inmunológicas, metabólicas, hematológicas y endócrinos*,¹² además de distintos trastornos en la comunicación afectando de esa forma su interacción con el medio que lo rodea.

De su totalidad son prematuros tardíos aproximadamente el 84 por ciento y la mayoría sobreviven con atención de apoyo, los muy prematuros requieren atención de apoyo adicional, y al igual que los anteriores, la mayoría sobreviven,

¹⁰ Diccionario de la Real Academia Española

¹¹ Rellan Rodríguez S. y cols. El recién nacido prematuro (2008), pág. 1

¹² Rellan Rodríguez S. y cols. El recién nacido prematuro (2008),pág. 70-74

pero el panorama es menos alentador para aquellos infantes con un nacimiento prematuro extremo, ya que requieren atención intensiva y costosa, en países desarrollados tienen 90 por ciento de posibilidades de sobrevivir pero pueden sufrir discapacidades, neurológicas, físicas y de aprendizaje. En países con ingresos bajos solo el 10 por ciento sobrevive.

Los niños que nacen prematuramente pueden presentar anormalidades funcionales como disminución del flujo sanguíneo cerebral, y estructurales las cuales hacen referencia al aumento en el volumen de las astas occipitales y temporales reducción de la sustancia gris cortical (González, 2005). Sin embargo, la tasa de supervivencia de los niños prematuros ha aumentado, especialmente de los nacidos con un peso por debajo de 1500g, gracias al avance medico enfocado en el cuidado del neonato (Picard, Dotto, Breslau, Yeates y Taylor, 2000; Volpe, 2001).

No obstante, con todos los esfuerzos por mejorar la expectativa de vida de esta población, los prematuros sin complicaciones, una vez fuera del vientre materno presentan reducción de la sustancia gris cortical, una afectación de la sustancia blanca y un aumento de los ventrículos laterales que se hará más notoria en edades avanzadas.

Pueden tener déficit en el coeficiente intelectual (CI) de los 3 a los 8 años como consecuencia de las dificultades respiratorias y limitaciones perinatales de oxigenación cerebral que son frecuentes, lo cual mantendrá a esta población por debajo de la media en relación a su CI, lo cual varia a partir de la estimulación cognitiva producto del ambiente, y de los 14 a los 15, como secuelas a largo plazo de la limitación de oxígeno tras el nacimiento pretérmino, se pueden presentar problemas en la lectura y el cálculo.

En tal sentido, el prematuro con complicaciones presenta leucomalaciaperiventricular, dilatación ventricular y atrofia de algunas estructuras subcorticales que en la infancia y hasta los 13 años puede desencadenar dificultades en el rendimiento cognitivo y en la memoria específicamente (Narberhaus&Segarra, 2004; González, 2005).

Entre las complicaciones más frecuentes derivadas de la prematuridad encontramos, deficiencias en el desarrollo neurológico, retardo en el crecimiento,

sordera, estrabismo, enfermedad pulmonar crónica, déficit de atención, problemas en el lenguaje, hernias y síndrome de muerte súbita (Vohr, Wright, Aylward y Hirtz, 2004; O'Shea, 2008). Así como los prematuros extremos tienen 100 veces más probabilidad de presentar parálisis cerebral que aquellos que tuvieron un periodo de gestación completo (O'Shea, 2008).

En cuanto a las consecuencias que trae la prematuridad para el desarrollo del lenguaje Werker y Yeung (2005), consideran que el impacto de la exposición prematura al lenguaje parece no tener efectos perjudiciales evidentes sobre la adquisición de la fonología de los prematuros porque una vez fuera del útero es posible que estos niños retrasen el inicio de períodos sensibles al aprendizaje del lenguaje.

Los niños prematuros muestran habilidades menores en el léxico y la gramática, también se evidencia mayor tasa de riesgo de retraso léxico y/o ausencia de combinación de palabras que los niños nacidos a término. En general, algunos de los niños prematuros presentan retraso generalizado en las competencias lingüísticas y cognitivas; retraso específico en el lenguaje, y deficiencias cognitivas específicas. Los niños prematuros extremos muestran un factor de riesgo mayor para el retraso lingüístico a los 2 años, lo que indica que, en algunos niños, esta parece ser la expresión de una deficiencia cognitiva general, mientras que en otros es específica para el lenguaje.

Los niños prematuros cuando nacen muestran muchas anomalías neuromotoras las cuales en ocasiones pueden persistir y acompañarse de un retardo y/o trastorno motor así como también un trastorno motor fino, alteraciones en la función ejecutiva, déficit visoespacial, visoperceptual y problemas con la ejecución motora. Los trastornos motores en estos niños pueden ir desde una parálisis cerebral ligera-severa, hasta disfunción neuromotoras o trastorno en el desarrollo de la coordinación. Para muchos prematuros el trastorno motor es menos discapacitante que las alteraciones asociadas a ellos, esfera ejecutiva, trastornos cognitivos y motor fino.

Considerando los problemas emocionales y conductuales los datos actuales indican que son más comunes en niños pretérmino que en controles a término,

con una elevada prevalencia del déficit de atención e hiperactividad, conductas antisociales, ansiedad y depresión.

Según los estudios realizados sobre, Neuropsicología del lenguaje de niños entre 6 y 10 años de edad con antecedente de nacimiento prematuro, se concluye que en lo que se refiere a la acción verbal las estructuras gramaticales y narrativas se ven comprometidas así como los elementos sintácticos que involucran aspectos fonológicos de imitación verbal, con tendencia a que estas dificultades mejoren con el paso de los años.

El procedimiento más adecuado para garantizar y optimizar su desarrollo, no solo en el área del lenguaje sino en las diferentes áreas del desarrollo, es la prevención primaria; ya que así se evita muchas tramas en el desarrollo del niño como la familia.

Se hace evidente la oportuna prevención de los trastornos del lenguaje en estos niños prematuros por lo que su incidencia transita por la detección temprana de ello.

Capítulo II. Propuesta de un conjunto de actividades para la atención logopédica comunitaria en la prevención de los trastornos del lenguaje.

En este capítulo se realiza la operacionalización de la variable, el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, se fundamenta las actividades profilácticas para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros, así como su estructura, funcionamiento y su valoración mediante su aplicación en la práctica pedagógica.

2.1 Operacionalización de la variable

Para la realización de la investigación se asume una fundamentación teórico-metodológica sobre la definición de variable dado por Morales, E. (2006) al enunciar que: “variable es cualquier cualidad o característica de una persona, animal o cosa susceptible de ser medida”¹³ teniendo en cuenta que el termino seleccionado se ajusta al estudio que se investiga **se determina como variable dependiente: la atención logopédica comunitaria** la cual se asume como un **proceso** especializado que se concreta en los diferentes **contextos educativos** donde se **previenen, corrigen y/o compensan** en condiciones de cooperación, las **alteraciones del lenguaje**, en un enfoque **preventivo de inclusión social** para la atención logopédica para un óptimo desempeño de las **habilidades comunicativas y sociales** en un entorno determinado con carácter intersectorial para el desarrollo del **lenguaje en niños prematuros** desde la comunidad. (Operacionalización del término Chacón, Durruthy. Y. 2019)

Teniendo en cuenta lo planteado por el autor Deler, G. (2006) al referirse a los indicadores como: “*aquellos que designan y describen de modo sintetizado, la unidad de los elementos constitutivos del proceso estudiado.*”¹⁴

¹³Morales Jiménez, E. Nociones Estadística para profesionales de la salud. Instituto Superior de Ciencias de la Habana. Facultad Finlay-Albarán. Soporte digital. Cuba. 2006. pág. 26.

¹⁴Deler Ferrer, G. Estrategia para el desarrollo de la actividad investigativa del docente en el centro de referencia. Tesis de grado. 2006. pág. 47.

Indicadores	Métodos	Instrumentos
I. Nivel de preparación de los maestros logopedas y médicos de la familia para la implementación de la atención logopédica comunitaria.	Observación Entrevista	Guía de Observación Guía de entrevista
II. Nivel de conciencia de la familia sobre las consecuencias de la prematuridad en el desarrollo del lenguaje del niño.	Observación Encuesta	Guía de Observación Guía de encuesta
III. Nivel de influencia de la comunidad en el desarrollo del lenguaje en niños prematuro.	Observación Entrevista Encuesta	Guía de Observación Guía de entrevista Encuesta especialistas y usuarios

Los indicadores serán evaluados de alto (80 a 100%) si contestan más de 4 preguntas, medio (50 a 80%) si responden 3 y bajo (menos de 50%) si responden menos de 2. Esto permitirá identificar las principales fortalezas y debilidades en la práctica educativa.

La variable independiente es la propuesta de un conjunto de actividades profilácticas para el desarrollo de la atención logopédica comunitaria en la prevención de los trastornos del lenguaje.

2.2 Caracterización del estado inicial de la atención logopédica comunitaria en niños prematuros con trastornos en el lenguaje.

Para el desarrollo y empleo de los distintos métodos empíricos en la evaluación de los indicadores se tuvo en cuenta el grupo de estudio que participó en la investigación y se realizó la firma de una carta de consentimiento informado (anexo 1), de carácter jurídico donde se encuentra involucrado el investigador con los investigado en el cual aceptaban su participación en el proceso de investigación. Se realizó el análisis documental (Anexo 2) de cada niño investigado así como otros documentos de interés para la investigación que como resultado se determinó la existencia de trastornos del lenguaje que pueden presentar los niños prematuros en esta comunidad y la importancia que tiene su prevención. Se realizó la guía de observación (Anexo 3) a maestros logopedas, médicos de la familia, la familia del prematuro y a los agentes comunitarios con la intención de divisar su preparación, participación en la prevención de los trastornos del lenguaje y la inclusión social a la comunidad, además se realizaron exploraciones logopédicas para conocer el diagnóstico de los prematuros. Se llevó a cabo una entrevista a 5 maestro logopedas y otra entrevista a 4 médicos de la familia. Se les aplicó una encuesta a 10 madres del municipio la Lisa.

Los resultados obtenidos durante la **observación** fueron los siguientes:

La exploración logopédica realizada (Anexo 4) se comprobó que de los 10 niños prematuros evaluados, 5 de ellos presentan trastornos en el lenguaje, 2 presentaron Retraso en el Lenguaje. Se aprecia un buen estado articulatorio. Todos respondieron bien a los estímulos sonoros que se le fueron presentados. En cuanto a la conversación no se logró que fuese espontánea y coherente debido a que presentan dicho trastorno. El desarrollo del vocabulario pasivo y activo no está relacionado con la edad cronológica de los niños.

No tienen un uso adecuado de artículos, preposiciones y adjetivos teniendo en cuenta su edad cronológica. No logran articular correctamente los sonidos y presentan dificultad en la conjugación verbal y en la concordancia entre género y número, por lo que necesitan niveles de ayuda. Ejecutan órdenes y acciones, solo 3 necesitan ayuda para la realización de esta.

Su ritmo y fluidez es normal de acorde con el biotipo y la edad. La intensidad de su voz es normal, tono medio, timbre sonoro y entonación melódica. Son capaces de rellenar figuras colorear, rasgar, trazar.

En cuanto a la valoración de los resultados obtenidos de **la entrevista a maestros logopedas** (anexo 5) 3 maestros logopedas tienen conocimientos sobre las características que presentan los niños prematuros y la influencia de estos en el desarrollo del lenguaje, 5 presentan buen dominio de los trastornos del lenguaje y cuáles son los más comunes que ellos pueden presentar. En cuanto a la atención logopédica comunitaria 2 presentaron un poco de dudas debido a que era un término que no habían escuchado hablar.

En **la entrevista realizada a los 4 médicos de la familia** (anexo 6) se pudo comprobar que los 4 tienen buen dominio del sobre las etapas del desarrollo del embarazo, los 4 tienen conocimiento sobre la prematuridad y las consecuencias que esto podría provocar en el desarrollo del niño solo 1 presento dificultad en determinar cuáles eran las principales causas del desarrollo ontogenético del niño que les provocaría trastorno en el lenguaje.

En **la encuesta realizada a las 10 madres** de los niños prematuros (anexo 7) 2 de las madres padecieron de enfermedades durante el embarazo, 3 de ellas no tenían conocimiento de que la prematuridad era una de la principal causa de que sus hijos no hayan podido desarrollar el lenguaje, 4 de ellas no tienen noción de que son los trastornos del lenguaje ni como estimularlo. En cuanto al estímulo del lenguaje 5 buscan las vías necesarias para su desarrollo y 5 opinan que no lo realizan debido a que trabajan y los niños se quedan con cuidadoras o familiares cercanos. En la consultas con especialista clínicos solo 3 es atendido hasta la actualidad.

La caracterización y resultados del estado inicial de la atención logopédica comunitaria en niños prematuros con trastornos en el lenguaje pudieron determinar cómo fortalezas y debilidades las siguientes:

Fortalezas

- Los maestros logopedas tiene buen dominio sobre cómo trabajar la atención logopédica desde la comunidad
- La familia está dispuesta a ser partícipe del desarrollo de sus hijos contribuyendo a la creación del punto logopédico.
- Los niños explorados no presentan afectación en los sistemas sensoriales.

Debilidades

- Falta de preparación de la familia para estimular el desarrollo del lenguaje de sus hijos.
- No existe proyectos en la comunidad que contribuyan al desarrollo del lenguaje en el niño.
- Los niños prematuros estudiados necesitan estimulación del lenguaje.

El indicador más afectado es:

II. Nivel de conciencia de la familia sobre las consecuencias de la prematuridad en el desarrollo del lenguaje del niño.

A partir del análisis de los resultados se pudo constatar la necesidad de buscar una alternativa de atención logopédica que involucre a la escuela, la familia y las agencias y agentes sociales y comunitarios para prevenir los trastornos del lenguaje en niños prematuros de la comunidad Versalles- Coronela del municipio La Lisa.

Los resultados obtenidos se representan a continuación:

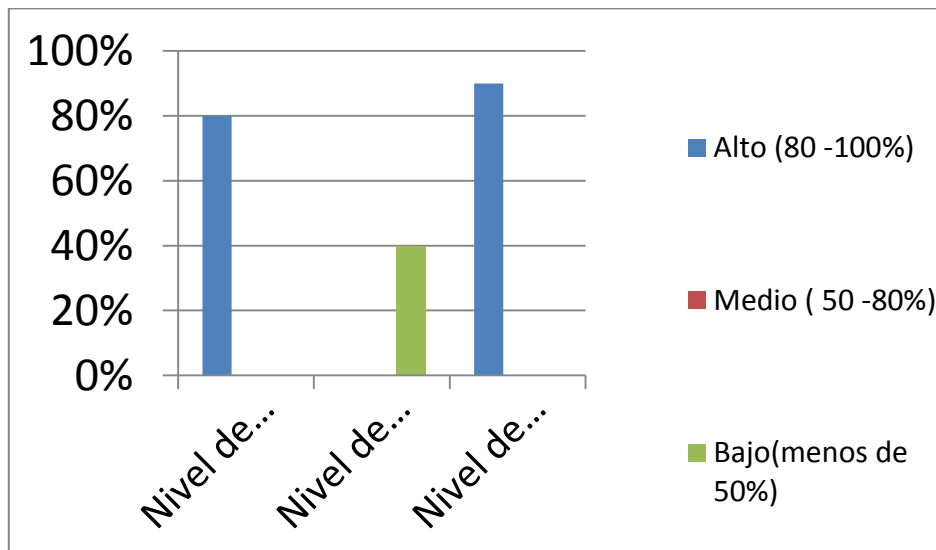


Gráfico 1.1

2.3 Fundamentación teórico metodológica de la propuesta de actividades profilácticas para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros.

El método teórico modelación permitió el diseño de las actividades para el trabajo de la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros.

Actividad: Mediatiza la vinculación del sujeto con el mundo real. Es la manifestación externa de lo que se hace. Capacidad de hacer o actuar sobre algo, conjunto reacciones, tareas. Colectivo de autores, 1998. En el diccionario filosófico de M. Rosentall y P. Ludin se plantea que la actividad es la función del sujeto en el proceso de interacción con el objeto, es un nexo específico del organismo vivo con el medio que lo rodea, es estimulada por la necesidad, se orienta hacia el objeto que le da satisfacción y se lleva a cabo mediante un sistema de acciones.

Según Deler, G (2006), *plantea que la actividad son las acciones y operaciones que como parte del proceso, desarrollan los estudiantes con la mediatización del profesor para la enseñanza aprendizaje del contenido de la educación*¹⁵. La autora de esta investigación asume la definición de actividad dada por Deler (2006), puesto que a través de las actividades el logopeda profundizara los conocimientos del niño.

Estas actividades propuestas permite determinar que se desarrolla con un **carácter profiláctico** de los trastornos del lenguaje, término que proviene del vocablo profilaxis el cual plantea desde lo clínico que es *aquello que se lleva a cabo o se utiliza para prevenir la aparición de una o varias enfermedades o trastorno*¹⁶, por lo que desde lo pedagógico se tienen en cuenta por su acercamiento al contexto educativo donde se tiene en cuenta lo bio-psico-social del individuo y están dirigidas a prevenir los trastornos existentes en los sujetos, es decir la unidad de las ciencias en función del sujeto y procesos investigados. Las actividades profilácticas desde el área educacional no son más que todas las acciones que se realizan para prevenir los trastornos que puedan aparecer en las personas y desde lo logopédico en la comunicación y el lenguaje.

¹⁵ Deler Ferrer, G. Estrategia para el desarrollo de la actividad investigativa del docente en el centro de referencia. Tesis de grado. 2006.

¹⁶ www.diccionariodefinición.de.com

2.3.1 Fundamentación teórica metodológica de la propuesta de actividades profilácticas

Desde las distintas ciencias prevenir, educar, orientar y apoyar a partir de funciones y tareas del bienestar de cada uno de los miembros de la comunidad. Con la práctica logopédica se ha demostrado que muchos procedimientos propios de estas ciencias pedagógicas constituyen vías para formar, desarrollar y educar el lenguaje.

La propuesta de actividades para la prevención de los trastornos lenguaje en niños prematuros va dirigida a desarrollar la creatividad, la imaginación e influyen en el desarrollo psicomotor, en la intelectualidad, la personalidad y el lenguaje. Estas a su vez liberan energía, estimulan las facultades de coordinación y orientación espacial por lo que fortalecen la confianza tanto sí mismo como en los demás.

Es por ello que la propuesta se sustenta bajo los fundamentos filosóficos, biológicos, pedagógicos, sociológicos, psicológicos, didácticos y lingüísticos. En ella se tiene en cuenta que el hombre es un ser bio-psico-social donde mantienen vínculos dialecticos con todo aquello que lo rodea permitiéndole estar en total evolución, cambio y transformación, logrando así solucionar sus propias necesidades y su relación con la sociedad.

Las actividades propuestas permiten el estudio y análisis de los objetos y fenómenos de la realidad de forma objetiva, integrada, multilateral y favorece la comprensión en su totalidad sobre el estudio del desarrollo del lenguaje en estos niños.

En su elaboración se tiene en cuenta que todo hombre es educable, ya sea con una discapacidad o no, que tienen el derecho de ser preparado para la vida y el trabajo sin importar condición social. Los niños prematuros no se encuentran expenso de estos ya que es una condición con la que se nace y no se elige raza, color ni sexo y a pesar de su corto desarrollo fetal su cerebro le permite procesar las funciones corporales homeostáticas debido a su neuroplasticidad y este produce la percepción sonora del habla en los hemisferios izquierdo y derecho transfiriendo así las informaciones al área de Wernicke y este al de Broca desarrollando el lenguaje como actividad fundamental.

Estas actividades ayudan al niño prematuro a desarrollar el lenguaje, articular los sonidos correctamente y a prevenir, corregir y/o compensar los trastornos que puedan aparecer en este periodo de edad, les permiten expresar sentimientos, emociones e inquietudes, posibilita también la profundización en las categorías como: situación social del desarrollo, vivencia, mediación del desarrollo psíquico, niveles de ayuda, la categoría “otros”. Es por ello que encuentran en total relación con la comunidad, la familia y el niño debido a que son el centro y la razón esencial de toda labor pedagógica ya que contribuye de una manera directa al desarrollo integral del niño prematuro. Permite al maestro logopeda vincularse con los demás agentes educativos de la sociedad, además de rediseñar las acciones, caracterizar las relaciones sociales dentro de la escuela, la familia y la comunidad. Todo hace posible que a través de las relaciones interpersonales, el mundo exterior y momento histórico en que se encuentran viviendo puedan lograr una mayor comprensión entre las funciones que debe realizar el niño con el medio que los rodea para prevenir los trastornos del lenguaje.

2.3.2 Estructura y funcionamiento de la propuesta de actividades profilácticas:

Las actividades diseñadas para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros presentan las siguientes estructuras: título, objetivo, medios de enseñanzas, material verbal y descripción de las actividades.

Las actividades diseñadas tienen en cuenta la edad de los niños, sus vivencias y características del medio, responden a sus necesidades y se basa además en la actividad principal de esta etapa que es el juego. Estas se realizarán en la comunidad, en el hogar y en el punto logopédico y variarán según la orden de las actividades. Las descripciones de las actividades indican que debe hacerse y cómo se debe hacer. La propuesta tiene un periodo de aplicación de 3 meses, 1 vez por semana en el punto logopédico, para garantizar el seguimiento a estas actividades se trabajará en conjunto con la familia y la comunidad un tiempo de duración de 15 a 30 minutos.

Al concluir cada actividad se evaluará al niño según como sea su desempeño y participación en cada actividad. Estas evaluaciones serán de bien si el niño logra responder todas las preguntas que se le hacen, establecer una conversación o

realiza correctamente las actividades orientadas, de regular si necesita niveles de ayuda para dar una respuesta adecuada, si no logra realizar una conversación fluida, se evaluara de mal si no logra realizar ninguna actividad, no establezca conversación, no responda y se muestre negativo durante el tiempo de trabajo. Para poder evaluar se tendrá en cuenta la edad cronológica del niño y el desarrollo del lenguaje. Estas evaluaciones no se le dirá al niño, sino a la madre y se le indicara el proceder para el trabajo continuo en la casa.

Propuesta de actividades profilácticas (ver anexo # 9)

No	Titulo	Objetivo
1	Aprendiendo a soplar	Ejercitar el soplo para la correcta producción del habla
2	Jugando a soplar	Ejercitar el soplo para la activación de los músculos de los labios
3	Mi familia feliz	Reconocer los miembros de la familia incentivando el amor hacia ellos
4	Mi visita al zoológico	Pronunciar palabras para la estimulación del lenguaje incentivando el amor hacia los animales
5	Ayudando a prevenir	Nombrar los objetos de la casa partiendo de las labores del hogar realizado por mamá
6	El juego de las palabras	Pronunciar palabras mediante el juegos
7	El mundo de las frutas	Activar la memoria auditiva mediante juegos
8	Jugando aprendo yo	Ampliar el lenguaje mediante el juego
9	Aprendiendo a articular	Pronunciar palabras alargando las vocales estimulando así el lenguaje
10	Los cuentos de mami	Ampliar el lenguaje mediante la lectura de cuentos

Figura 1. Actividades profilácticas

2.4 Valoración para la puesta en práctica pedagógica de la propuesta por criterio de especialistas.

Con objetivo de validar preliminarmente la propuesta se le aplicó a 10 especialistas con 10 o más años de experiencia y fue aplicada mediante el método empírico consultas a especialistas (Anexo 10). Según la opinión de los especialistas con respecto a la propuesta diseñada en muy adecuada, adecuada, poco adecuada y no adecuada.

Teniendo en cuenta que la propuesta diseñada se obtuvo durante la consulta a especialistas en los aspectos a evaluar fueron los siguientes resultados:

- En cuanto a la estructura de las actividades el 20 % de los especialistas consideran la propuesta muy adecuada y el 80% adecuada permitiendo su aplicación, teniendo en cuenta la forma de estructuración: título, medios de enseñanza, material verbal, descripción, evaluación.
- Relacionado con el contenido de las actividades el 100 % de especialistas opinan que la propuesta es adecuada.
- Respecto a la descripción de las actividades el 40 % opinan que la propuesta es muy adecuada y el 60% lo considera adecuada.
- En cuanto a los resultados que se espera obtener con la propuesta diseñada el 100% de los especialistas opinan que es adecuada.

En general existe un acuerdo en que la propuesta de un conjunto de actividades para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros:

- Es adecuada la estructuración.
- El contenido de las actividades son variadas, responden a los intereses de los niños y permite estimular el lenguaje en ellos.
- Las descripciones de las actividades se corresponden con la edad cronológica de los niños, se enmarcan en el juego como la etapa principal de ellos.

Siendo consecuente con lo antes expuesto se constata la necesidad de aplicar la propuesta de actividades profilácticas concebidas.

2.4.1 Implementación de la propuesta en la práctica educativa

La investigación se desarrolla en la comunidad Versalles– La Coronela, en el municipio Lisa. Para la prevención de los trastornos del lenguaje en estos niños se aplicó con una frecuencia de 1 vez por semana con una duración de 20 min un conjunto 10 actividades profilácticas durante el curso escolar (2019 – 2020). Las condiciones para su desarrollo fueron favorables y se realizó en un ambiente tranquilo lo que permitió la cooperación de los niños y padres que se encontraban presentes. Las actividades fueron realizadas en el punto logopédico y en hogar. Los usuarios como las 10 madres, 3 miembros de la comunidad (Médico de la familia, agente de seguridad de la escuela, círculo de abuelo) (Anexo 11) y 4 familia de niños con otros trastornos del lenguaje (dislalia) que opinaron el 97% de aseveración positiva de las actividades desarrolladas en la comunidad y de los avances de los niños de la propuesta y su inserción social educativa. Por lo que se considera viable a ser aplicada a otros contextos del mismo municipio implicado en la investigación.

Conclusiones

- Con el análisis de los referentes teóricos metodológicos que sustentan a la atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastorno del lenguaje niños prematuros tiene como base un enfoque histórico cultural puesto que refleja que el niño es un ser pisco- social y que sus primeros estímulos provienen de la comunidad. En el influye el papel de los maestros logopeda y agentes sociales que son los encargado a la formación integral de ellos conjunto con la familia.
- La caracterización de estado inicial revelo las dificultades que existen en los niños prematuros del reparto Versailles – Coronela en cuanto al desarrollo del lenguaje y el alto riesgo que tienen presentar trastornos del lenguaje.
- Las actividades profilácticas diseñada ayuda al maestro logopeda al trabajo preventivo de los trastornos del lenguaje en niños prematuros permitió la vinculación de la teoría y la práctica, la relación entre la familia, la comunidad y el logopeda ayudando de esta forma a cumplir con el objetivo de la atención logopédica comunitaria.
- El resultado obtenido con la aplicación de la propuesta permite concretar que se hace necesario el trabajo con estos niños prematuros, se evidencia de forma positiva los avances que ellos han logrado en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje.

Recomendaciones

- Seguir profundizando sobre los elementos teóricos y metodológicos que abordan el tema de la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros.
- Continuar profundizando en la atención logopédica comunitaria para la corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje.
- Crear nuevos proyectos socioeducativo donde la familia tenga el rol fundamental en la estimulación del lenguaje.

Referencias bibliográficas

1. Fernández. G: Logopedia I, Editorial pueblo y educación, p.46
2. Raya Diéguez. E.: Fundamentos de trabajo social comunitario. Editorial Alianza S.A. 2008. Madrid. España. Pág. 45. ISSN 84-206-4726-8
3. Arredondo Kassabb. MM.: Aplicación de buenas prácticas socioeducativa para la atención logopédica en niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la comunidad. Perfil Proyecto 2015.
4. Gómez Salas. L. (2017): Operalización del constructo según el objeto a estudiar. Tesis de Diploma 2016.
5. Arredondo, MM: Art. La atención logopédica comunitaria. El Punto Logopédico. Revista Google Académico. (2015). Cuba. Pág. 3
6. Tought, 1987, pág. 23
7. Dr. Gómez López S. La prevención de dificultades del lenguaje oral en el marco escolar (2015)
8. Diccionario de la Real Academia Española.
9. Arredondo, M, M: Atención logopédica comunitaria. Artículo Revista REDIFE ISBN: 978-1-945570-14-8. Cuba- Colombia. 2015. Pag.6
10. Diccionario de la Real Academia Española
11. Rellan Rodríguez S. y colgs. El recién nacido prematuro (2008), pág. 1
12. Rellan Rodríguez S. y colgs. El recién nacido prematuro (2008), pág. 70-74
13. Morales Jiménez, E. Nociones Estadística para profesionales de la salud. Instituto Superior de Ciencias de la Habana. Facultad Finlay- Albarran. Soporte digital. Cuba. 2006. pág. 26.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

14. Deler Ferrer, G. Estrategia para el desarrollo de la actividad investigativa del docente en el centro de referencia. Tesis de grado.2006. pág. 47.
15. Deler Ferrer, G. Estrategia para el desarrollo de la actividad investigativa del docente en el centro de referencia. Tesis de grado.2006.
16. www.diccionariodefinición.de.com

Bibliografías

1. Alixandra González Picarín, O. C. (04 de 12 de 2014). El proceso de atención logopédica a escolares del nivel primario desde una perspectiva pedagógica.
2. Arredondo, Kassabb.M.M.(2015) La atencion logopedica comunitara. Retos de la actualidad cientifica. Artículo REDIPE ISSBN1992-8338-2019. La Habana.
3. Arredondo, Kassabb.M.M. (2015) Aplicación de buenas prácticas socioeducativa para la atención logopédica en niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la comunidad. Perfil Proyecto. Proceso de acreditación.
4. Blanco, A: Introducción a la Sociología de la Educación. Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 2003
5. Bernal, J. L. (1998). *Fundamentos del trabajo social comunitario*. España.
6. Cobas Ochoa, Carmen: La preparación logopédica del maestro. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2010.
7. Calviño M: Conferencias de Universidad para Todos. Pensar y conocer Psicología. La atención en las comunidades. 2015
8. Camacho, R., Yokabet, M., y Jimenez, F.: La comunidad y su entorno. Editorial Paidos. Argentina. 2010
9. Colectivo de autores. Los métodos para la exploración logopédica, Editorial de libros para la Educación, 1979.
10. Deler, G. (2006). *El resultado científico en la investigacion pedagogica*
11. Delgado Jiménez, I. (s.f.). EL gabinete de orientación logopédica como espacio formativo y de interacción con la comunidad.
12. Fernández Díaz. A.: Algunas consideraciones sobre el cómo en la interrelación de los centros docentes y la comunidad. Editorial Pueblo y Educación. Cuba. 2008.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

13. Fernández Pérez de Alejo Gudelia, La atención logopédica en la edad infantil, Editorial Pueblo y Educación, 2008.
14. Fernández Pérez de Alejo Gudelia y Rodríguez Fleitas Xiomara, Logopedia I y II parte, Editorial Pueblo y Educación, 2012.
15. Fernández Pérez de Alejo, G., & Huepp Ramos, F. (2014). *Fundamentos Neuropsicológicos del Lenguaje*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
16. Gabriela Allignani a, G. G. (s.f.). Evaluación del Lenguaje en El niño nacido prematuro. *Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá*.
17. García, D. J., & Daweel, D. A. (2012). *Cartas de tu Bebé* (Dixie Edith Trinquete ed.). La Habana, Centro Havana, Cuba: de la Mujer.
18. García, T. F. (2009). *Fundamentos del trabajo social*.
19. Gustavo Granovsky, M. I. (s.f.). Desarrollo del lenguaje en niños nacidos prematuros .
20. I. Schapira a, N. A. (s.f.). Desarrollo alejado De Niños NaciDos Prematuros. *Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá*.
21. Leal., L. E. (2008). *EL DESEMPEÑO PROFESIONAL Y HUMANO DE LOS*. Cuba.
22. Lic. G. Rodríguez a, L. S. (s.f.). AvAtAres en premAturos de 3 A 5 Años y sus mAdres. *Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá*.
23. SILVIA DOMÉNECh MARTÍNEZ, J. P. (2014). Lenguaje y Prematuridad.
24. Rodríguez Fleitas Xiomara, información digital, conferencias del diplomado de logopedia. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, 2017-2018.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

25. Pérez, D. R. (2013). *Fundamentos Psicológicos, Segunda Parte II* (Lic. Daniel Vicente Cabalero Faure ed.). La Habana, Playa, Cuba: Pueblo y Educación.
26. Petrovski, P. A. (1980). *Psicología General*. URSS : Progreso.
27. Vigotsky L. S. Desarrollo de las funciones psíquicas superiores, Moscú, Editorial de la ACP, de la RSFSR, 1960.
28. VIGOTSKY, L. S. Obras Completas. Tomo V. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación; 1995.
29. VIGOTSKY, L. S. Pensamiento y Lenguaje. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación; 1982.
30. _____: La atención logopédica comunitaria. Proyecto socioeducativo comunitario "Pequeños Gigantes" REDIPE Educar para la vida 978-958-8967-13-4. Libro de memorias digital. Cuba- Colombia.

Anexo # 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Estamos solicitando a usted su cooperación voluntaria para incluirse dentro de la investigación que se desarrollará en la comunidad Versalles – La Coronela, con el objetivo de realizar un diagnóstico de los factores que intervienen en el pobre desarrollo del lenguaje de las niñas/os prematuros , y a partir del mismo diseñar un sistema de actividades profilácticas para este evento.

Si acepta participar, tiene derecho a abandonarla en el momento que estime conveniente.

Agradecemos su colaboración, si le surge alguna duda puede realizar las preguntas que necesite.

Si ha comprendido lo anterior y está de acuerdo en participar, le rogamos no los indique.

Declaración de voluntariedad:

He comprendido el propósito de este estudio y acepto voluntariamente participar como una de las personas de muestra.

FIRMA DE LA FAMILIA

FECHA

FIRMA DEL INVESTIGADOR

FECHA

Anexo 2

Guía para el Análisis documental.

Objetivo: Profundizar en documentos legales para la busca de información sobre la familia de los niños prematuros.

1. Revisión de documentos normativos y legales para la primera infancia.
 - 2- Expediente clínico
2. Exploración logopédica
3. Antecedentes patológicos familiares.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Anexo 3

Guía de Observación

Objetivo: Observar el nivel de preparación de los maestros logopedas, médicos de la familia y otros agentes educativos hacia atención a niños prematuros.

La información adquirida es completamente confidencial. Gracias por su ayuda.

No	INDICADORES	CATEGORÍAS			
		MB	B	R	M
I	Nivel de preparación de los maestros logopedas y médicos de la familia para la implementación de la atención logopédica comunitaria.				
1	Importancia que tiene el desarrollo de un embarazo sano				
2	Consecuencias de la prematuridad en desarrollo del niño				
3	Influencia de la prematuridad en el desarrollo del lenguaje				
4	Los trastornos del lenguaje más comunes que pueden presentar los niños prematuros				
5	Acciones que desarrollan para prevenir y estimular los trastornos del lenguaje en niños prematuros				
II	Nivel de conciencia de la familia sobre las consecuencias de la prematuridad en el desarrollo del lenguaje del niño.				
6	Conocimiento sobre la prematuridad				
7	Estimulación del lenguaje en hogar				
8	Acciones que realizan desde el hogar para prevenir los trastornos del lenguaje.				
III	Nivel de influencia de la comunidad en el desarrollo del lenguaje en niños prematuro.				
9	Actividades que realizan en la comunidad para incluir a los niños prematuros				
10	Influencia de la comunidad en el desarrollo del lenguaje de los niños prematuros				

Figura 2 : Guía de observación

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Anexo 4

Guía para la exploración logopédica

Actividad: exploración del lenguaje

Participantes: niños prematuros

Lugar de observación: local brindado por la comunidad

Objetivo: conocer si los niños prematuros presentan trastornos en el lenguaje

Aspectos a evaluar:

Nombre y Apellidos:

Procedencia del niño:

Fecha de nacimiento:

Motivos de consulta:

Datos concretos sobre la evaluación del lenguaje:

Examen específico el habla. Estado del aparato articulatorio:

Características de la audición:

Estado de la expresión oral. Conversación espontánea:

Vocabulario (volumen, calidad, significado):

Estructura gramatical (análisis de las características morfológicas):

Análisis de la pronunciación y de los PFF

FON	I	M	F	FOM	I	M	F	FOM	I	M	F	FOM	I	M	F
A				K				FL				EI			
E				G				GL				EU			
O				J				CL				OI			
I				T				BR				OU			
U				D				PR				IA			
M				N				FR				IE			
P				S				DR				IU			

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

B				L				TR				IO			
F				R				GR				UA			
CH				RR				CR				UE			
X				BL				AI				UI			
Ñ				PL				AU				UO			

Observaciones:

Ritmo y fluidez del lenguaje:

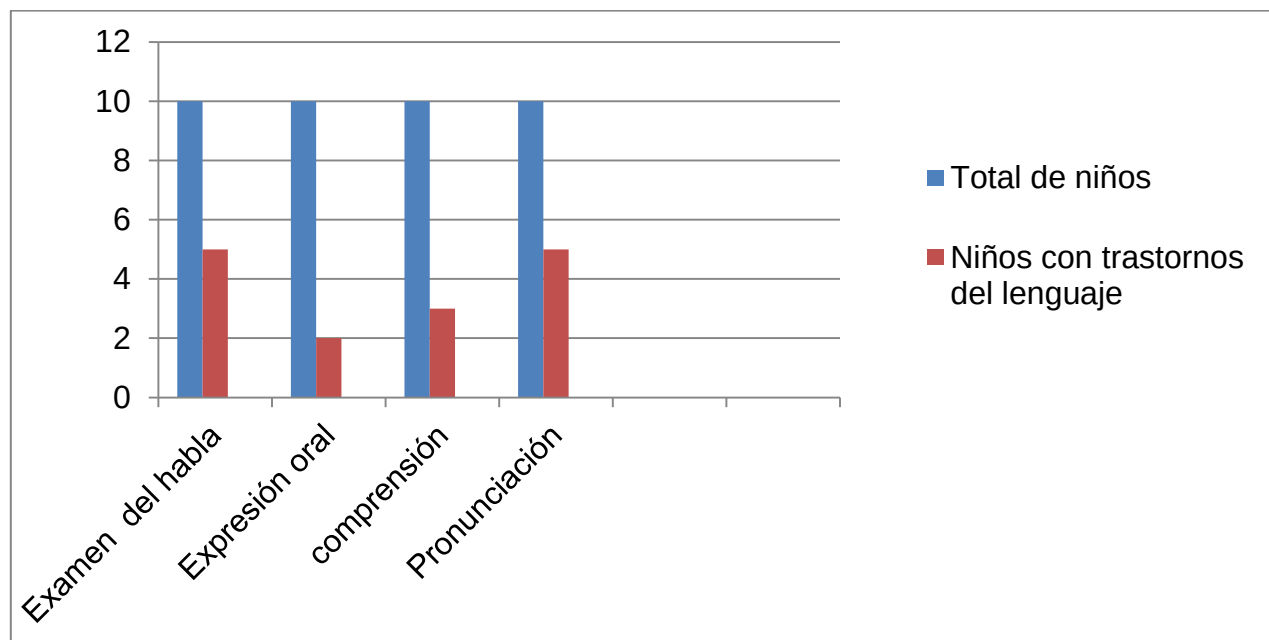
Características de la voz:

Conducta observada diariamente durante la prueba:

Diagnostico Logopédico:

Recomendaciones:

Gráfico 2.1: Resultados de la exploración logopédica



Anexo 5

GUÍA DE ENTREVISTA A LOGOPEDA

Estimados compañeros /as usted ha sido seleccionado teniendo en cuenta su efectiva labor profesional para formar parte del grupo de maestros que enjuiciara el siguiente trabajo, el cual consiste en la propuesta de un punto logopédico en el reparto Versalles – Coronela del municipio La Lisa la atención logopédica comunitaria en la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros.

Objetivo: Analizar cómo es la atención logopédica comunitaria que realiza para prevenir los trastornos del lenguaje en los niños prematuros.

Para recopilar su opinión le proporcionamos una serie de preguntas relacionadas con la propuesta.

Datos generales

Egresado: Si___ No___

Año de experiencia laboral:

I. Nivel de preparación de los maestros logopedas y médicos de la familia para la implementación de la atención logopédica comunitaria.

¿Sabe usted acerca de la prematuridad? Si___ No___

1. ¿Conoce usted sobre la influencia de la prematuridad en el desarrollo del lenguaje? Si___ No___

2. ¿Sabe cuáles son los trastornos del lenguaje más comunes que pueden presentar los niños prematuros? Mencione 3 de ellos. Si___ No___

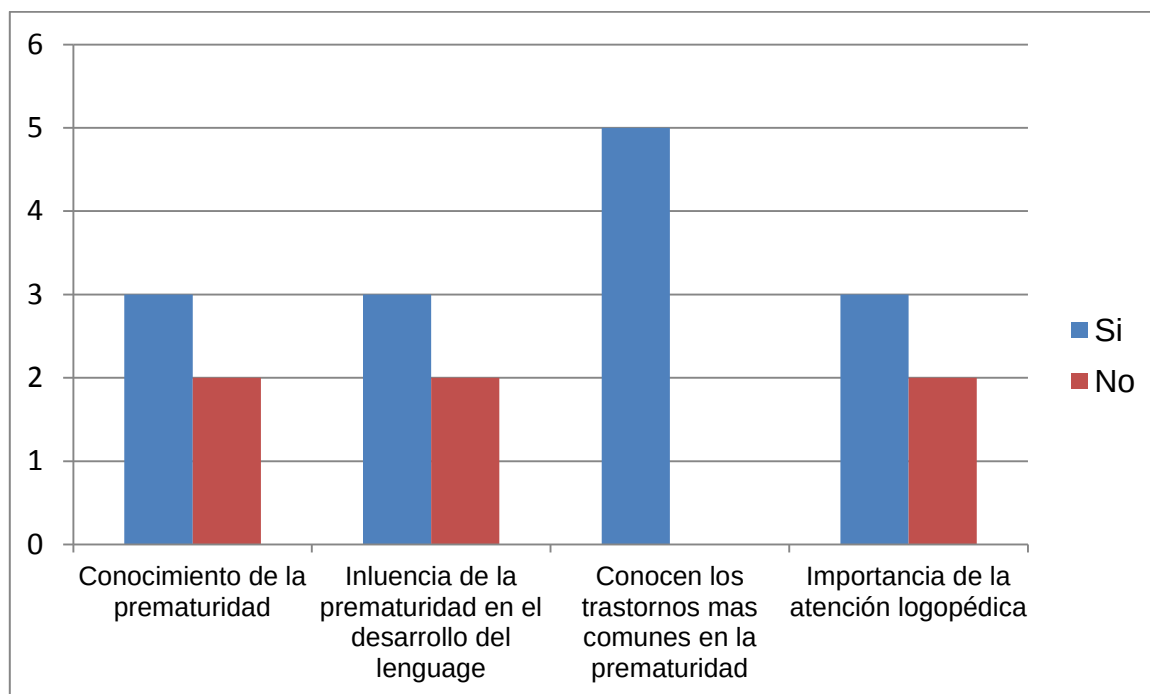
3. ¿Es importante para usted la atención logopédica comunitaria? Si___ No___

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

4. Teniendo en cuenta las particularidades de estos educandos, ¿qué importancia concede a la prevención del lenguaje en niños prematuros? ¿Qué actividades utilizas para su prevención?
5. ¿Con qué tipo de actividades se observa mayor motivación por parte de los niños prematuros?
6. ¿Qué opina sobre ofrecer actividades para la prevención de los trastornos del lenguaje en estos niños? ¿Por qué?
7. Utilizas recursos y apoyo para realizar las actividades ¿Cuáles?
8. ¿La familia recibe las orientaciones oportuna y variada para prevención de los trastornos lenguajes en sus hijos?
9. ¿Qué valor didáctico, pedagógico y psicológico le ofrecerías a la actividades para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros según sus necesidades?
10. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de elaborar de actividades para la prevención de los trastornos del lenguaje?
11. Pudiera darnos algunas sugerencias para continuar profundizando en el estudio de la prematuridad y las alternativas de atención logopédica que pudiera aplicar como novedosa.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Gráfico (3.1) Resultado de la encuesta aplicada a los maestros logopedas



Anexo 6

Guía de entrevista a médicos de la familia

Lugar: Consultorio 11. Versalles

Entrevistado (a): _____

Entrevistadores: Práctica docente 5to año carrera Licenciatura en Logopedia.

Estimados compañeros /as usted ha sido seleccionado teniendo en cuenta su efectiva labor profesional para formar parte del grupo de maestros que enjuiciara el siguiente trabajo, el cual consiste en la propuesta de un punto logopédico en el reparto Versalles – Coronela del municipio La Lisa la atención logopédica comunitaria en la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros.

Para recopilar su opinión le proporcionamos una serie de preguntas relacionadas con la propuesta.

Datos generales

Egresado: Si____ No ____

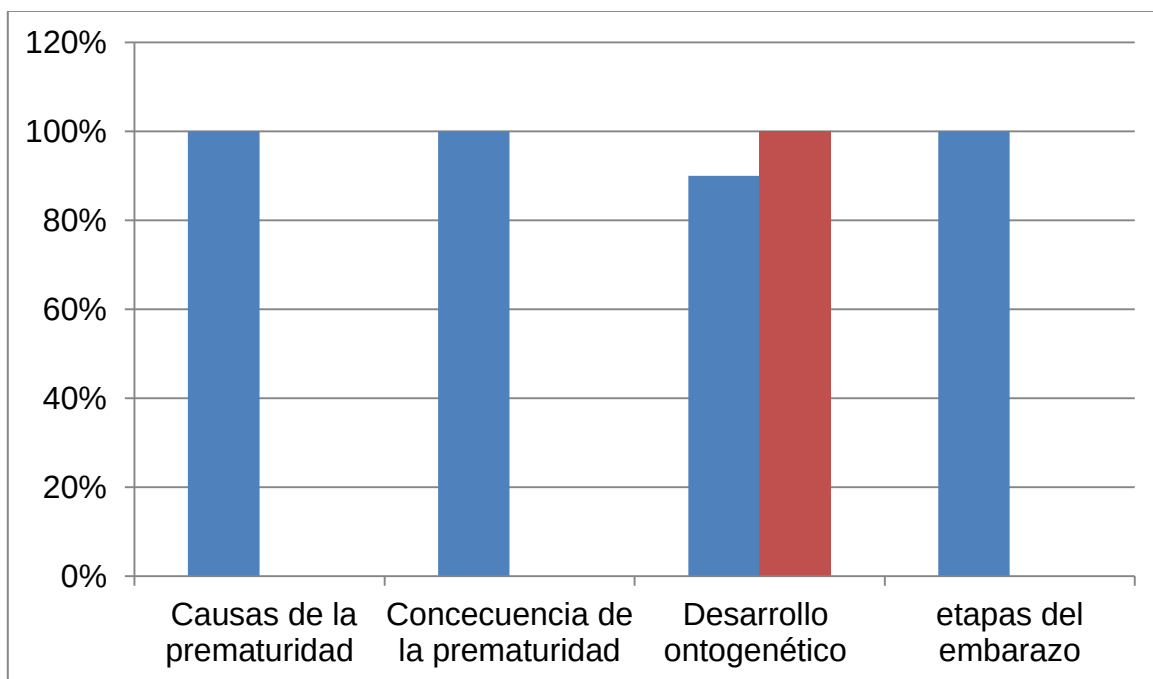
Año de experiencia laboral:

1. ¿Conoces las etapas del desarrollo del embarazo? Si__ No__
2. ¿Conoces son las principales causas que provocan la prematuridad?
Si____ No__
3. Desde su punto de vista clínico conoces las consecuencias que provoca la prematuridad en el desarrollo del niño. Si____ No__
4. ¿Qué datos según la historia clínica de las madres de los niños seleccionados, cree que son importantes para determinar posibles causas de trastornos en el lenguaje?

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

5. ¿Cree importante que las madres deban llevar una adecuada alimentación y nutrición antes, durante y después del embarazo? ¿Por qué?
6. ¿Cómo influye practique malos hábitos durante el embarazo? ¿Por qué?
7. ¿Qué consecuencias puede traer los malos hábitos de la madre al desarrollo ontogenético del niño?
8. Considera aportar otra información importanterelacionada con este tema. Explique
9. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de elaborar de actividades para la prevención de los trastornos del lenguaje?
10. Pudiera darnos algunas sugerencias para continuar profundizando en el estudio de la prematuridad.

Gráfico (4.1) Resultado de la encuesta a los médicos de las familia



Anexo # 7

Encuesta a la familia

Compañeros padres le pedimos su colaboración para la realización de esta investigación, le pedimos que nos respondan con mucha sinceridad.

- II. Nivel de conciencia de la familia sobre las consecuencias de la prematuridad en el desarrollo del lenguaje del niño.

Presento enfermedades durante el embarazo

Si___ No___

¿Conoce usted que son los trastornos del lenguaje?

Si___ No___

2. Conoces sobre las consecuencias que provoca la prematuridad en el desarrollo del lenguaje.

Si___ No___

3. Sabe usted como desarrollar el lenguaje en su niño

Si___ No___

4. ¿Realizan actividades para la estimulación del lenguaje? Si su respuesta es positiva mencione dos de ella

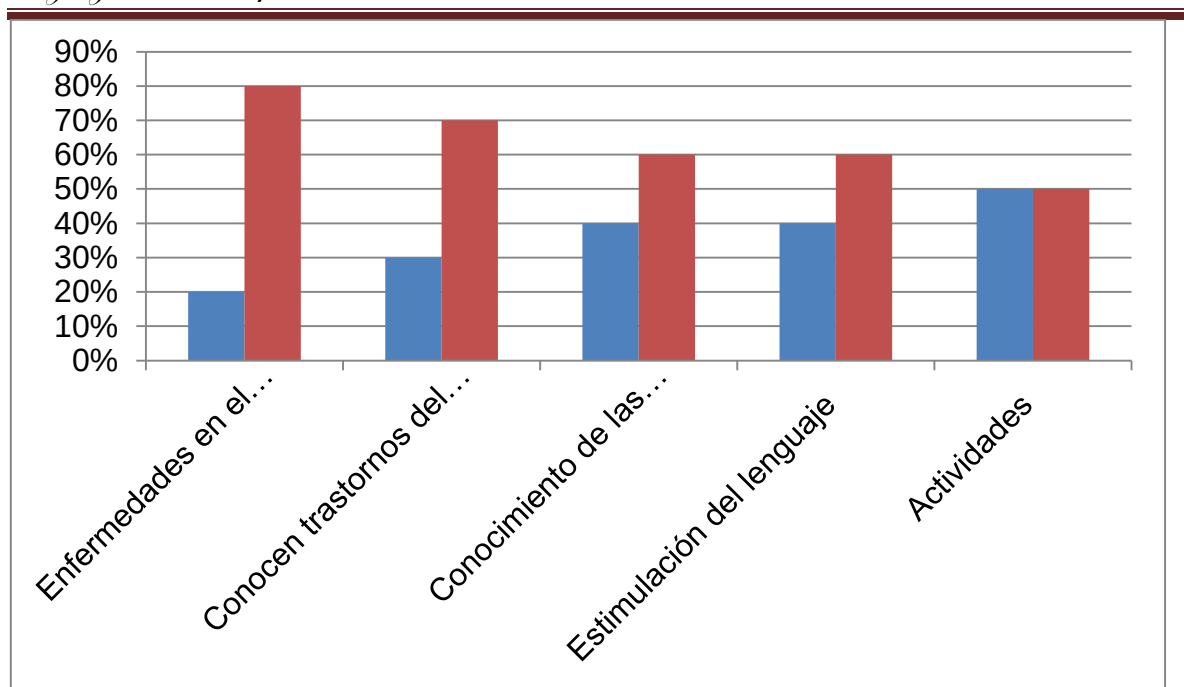
Si___ No___

5. En su comunidad existe otras opciones educativas como proyectos comunitarios que propicien el desarrollo del lenguaje. Menciónemelos algunos de ellos.

6. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de elaborar de actividades para la prevención de los trastornos del lenguaje?

Gráfico (5.1) Resultado de la encuesta a la familia

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros



ANEXO 8

Entrevista a los agentes comunitarios

Compañero/a necesitamos de su colaboración en esta investigación para conocer que dominios poseen en relación con la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros. Le agradeceríamos su sinceridad.

Objetivo: obtener información relacionada con el dominio que poseen acerca de la prevención del retraso del lenguaje.

III. Nivel de influencia de la comunidad en el desarrollo del lenguaje en niños prematuro.

- 1- ¿Conoce usted el término prematuridad? Explique
- 2- ¿Qué entiende usted por prevención de los trastornos del lenguaje?
- 3- ¿Qué métodos y vías conoce usted a través de los cuales se prevenga los trastornos del lenguaje?
- 4- ¿Realiza usted las actividades que se encuentran orientadas en el Programa “Educa a tu Hijo” en función de prevenir los trastornos del lenguaje?
- 5- ¿Qué opina usted sobre la propuesta de elaborar de actividades para la prevención de los trastornos del lenguaje?

Anexo # 9

Actividades Profilácticas

Actividad # 1

Título: Aprendiendo a soplar

Objetivo: Ejercitar el soplo para la correcta producción del habla

Medios de Enseñanza: globo, cartuchos de papel

Material verbal: soplar, globo, bolitas de papel

Descripción:

El niño debe pararse en posición recta, y jurará a soplar diferentes objetos como globos y cartucho de papel. A medida que va caminando aumentara la intensidad del soplo. Esto le permitirá al niño tener control de su respiración en la producción del habla.

Evaluación: bien, regular y mal

Actividad.# 2

Título: Jugando a soplar

Objetivo: Ejercitar el soplo para la activación de los músculos de los labios.

Medios de Enseñanza: caja, bolas de papel

Material verbal: soplar, bolas de papel, mesa y caja

Descripción:

El niño se debe sentar frente a la mesa junto con el logopeda, se coloca las bolas de papel una al lado de la otra y el niño soplara hasta ir colocando las bolas dentro de la caja. El logopeda le indicara como será la intensidad del soplo.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Evaluación: bien, regular y mal

Actividad # 3

Titulo: Mi familia feliz

Objetivo: Reconocer los miembros de la familia incentivando el amor hacia ellos

Medios de Enseñanza: láminas, computadora como reproductor de video

Material verbal: mamá, papá, abuela, nene, bebe

Descripción:

Se le muestra al niño una secuencia de láminas donde están presentes diferentes miembros de la familia en situaciones distintas.

Luego se le pide al niño que identifique los miembros de la familia que están presentes en las láminas mostradas estableciendo a través de estas preguntas estableciendo así una conversación espontaneas.

¿Quiénes son?

¿Qué tareas del hogar realizan?

¿Qué está haciendo la niña y el niño?

¿Cómo ayudas a tu mama en la casa?

Evaluación: bien, regular y mal

Actividad #4

Titulo: Mi visita al zoológico

Objetivo: Pronunciar palabras para la estimulación del lenguaje incentivando el amor hacia los animales

Medios de Enseñanza: láminas, computadoras, sonidos onomatopéyicos

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Material verbal: elefante, jirafas, león, tigre, elefante (otros animales del zoológico)

Descripción:

Se le muestra al niño diferentes láminas o ilustraciones sobre animales que habitan en los zoológicos. Se le explica al niño las características de estos animales, de que se alimentan y todo lo relacionado sobre ellos. Luego se le va mostrando cada animal y el sonido onomatopéyico que realizan.

Pasado 5 minutos se le realizan preguntas sobre los animales presentados en las láminas

¿Cómo está cubierto el cuerpo el león?

¿Qué comen las jirafas y los elefantes?

¿Dónde viven?

¿Quién realiza este sonido? (Sonido onomatopéyico del algún animal)

Evaluación: Bien, regular y mal.

Actividad #5

Título: Ayudando a prevenir

Objetivo: Nombrar los objetos de la casa partiendo de las labores del hogar realizado por mamá

Medios de Enseñanza: objetos del hogar

Material verbal: regadera, cuchillo, trapeador, escobas, (varía según la labor que se encuentre realizando la mamá).

Descripción:

Cuando la madre se encuentra realizando las labores del hogar debe ir nombrando los diferentes objetos que va utilizando. Se le dice al niño las

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

principales características, así como para que se utilizan, cuáles son sus semejanzas y diferencias en relación con los otros objetos. Pasado 5 minutos se le vuelve a preguntar al niño el nombre de cada uno de los objetos mostrados.

Evaluación: bien, regular y mal

Actividad #6

Título: El juego de las palabras

Objetivo: Pronunciar palabras

Medios de Enseñanza: tarjetas, voz del maestro, ilustraciones, videos infantiles

Material verbal: agua, mamá, papá, perro, gato, casa, tía

Descripción:

Se le dice al niño una palabra, este debe completar una frase con cada palabra dicha. Luego se le debe decir 4 a 5 palabras desordenadas y el niño debe ordenarla de tal forma que logre formar una frase. Se le dice una frase y este debe alargarla lo más que pueda.

Evaluación: bien, regular y mal

Actividad # 7

Título: El mundo de las frutas

Objetivo: Activar la memoria auditiva mediante juegos

Medios de Enseñanza: voz del maestro, láminas

Material verbal: mamey, mango, plátano, guayaba, guanábana, cereza, ciruela, fruta bomba, piña, naranja, mandarina

Descripción:

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Para el trabajo de la memoria se le dice al niño una secuencia de frutas. Luego pasados 5 minutos se le pide que lo repita con el mismo orden en que se le dijo al principio. Pasados otros 5 minutos se le muestra las láminas de las frutas en un orden y se le pide que trate de ordenarlas lo mejor que pueda teniendo en cuenta la misma secuencia en que se le dijo al principio.

Evaluación: bien, regular y mal.

Actividad #8

Título: Jugando aprendo yo

Objetivo: Ampliar el lenguaje mediante el juego

Medios de Enseñanza: láminas, lápices, teléfono, computadora

Material verbal: varía según el juego

Descripción

Esta actividad se centra en el juego del veo-veo. Se le pide a la familia que trabaje con el niño dependiendo a las categorías y fonética. Este le permitirá al niño concentrarse en lo que le preguntan y que debe responder

Trabajo por categorías:

- Veo-veo, algo de color.....
- Veo-veo, algo que es de forma.....
- Veo-Veo, algo que se utiliza para (escribir, leer , cantar, limpiar)

Trabajo con la fonemática:

- Veo-veo, algo que empieza con el sonido, t, f, s, l.

Evaluación: bien, regular y mal.

Actividad #9

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Titulo: Aprendiendo a articular

Objetivo: Pronunciar palabras alargando las vocales estimulando así el lenguaje

Materiales: láminas, tarjeteros

Material verbal: mamá, papá, nene, bebé, agua, tía, uña, casa, ojos, nariz

Descripción:

Se le pide al niño que se siente correctamente y que inhale lentamente aire por la nariz, retenerla y luego exhalar lentamente mencionando primeramente las 5 vocales,

Luego realizara el mismo procedimiento pero se le van incorporando las palabras poco a poco hasta que el logre hacerlo correctamente.

Evaluación: bien, regular y mal

Actividad #10

Titulo: Los cuentos de mami

Objetivo: Ampliar lenguaje mediante la lectura de cuentos

Medios de Enseñanza: Libro de cuentos de praxias

Material verbal: gallo, gallina, pato, vaca, cerdo, caballo, perro, (varía según el cuento que se lea)

Descripción:

En un ambiente saludable y tranquilo, se leerá al niño diferentes cuentos realizando las indicaciones que se les brinda en este libro.

Evaluación: bien, regular y mal.

Los animales de la granja

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Había una vez un hombre que vivía en una granja. Todos los días se levantaba muy temprano (Bostezar como sí nos estuviéramos levantando). Siempre lo hacía cuando cantaba su gallo Kiriko (kíkiríki, kíkíríkíííí,...). Luego se lavaba y después desayunaba leche y unas tostadas de pan muy ricas (Abrir y cerrar la boca primero despacio y después rápido, aumm, aumm,... imitando comer).

Seguidamente, se iba a cuidar a los animales. Primero limpiabala cuadras donde estaban, y lo hacía cantando (lalalala, lalalalalalala lale, lalalala lá lalalali,... se pueden seguir inventando diferentes ritmos). Todos los animales estaban muy contentos porque veían que el granjero estaba contento y lo dejaba todo muy limpio para que ellos estuvieran a gusto.

Después de haberlo limpiado todo, empezaba a dar palmadas (distintos ritmos de palmadas), diciendo:

- Todos a comer.

Y todos los animales se relamen, porque ya tenían hambre (mover la lengua de un lado para otro pasándola por los labios de arriba y luego por los de abajo, despacio y rápido. Luego apretarlos labios uuummmm, uum, uumm,...)

El granjero empezó a darle de comer a las gallinas:

- Hola gallinitas, (pita, pita, pita, pita, pííta,...)

Las gallinas lo recibían muy contentas (cooooco, cococoooooco,...) y los pollitos también (pío pío píooo...) y empezaban a picar el trigo que les echaba.

Después siguió con los patos:

- Hola patitos, y silbaba para llamarlos (intentar silbar varias veces, aunque solo salga el soplo).

Los patitos acudían rápidos (cuaca, cuaca,cuaaa...) y comenzaban a comer.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Luego se iba a donde estaban otros animales, la vaca, el cerdo, las ovejas y las cabras, a los que también saludaba.

-Hola, hola, (Hacemos participar a los niños para que digan varias veces el saludo, para que les puedan contestar los animales).

Y todos los animales contestaban alegres (la vaca: muuu, muuu, muuu,.... el cerdo: oinnn oíinnn oíinnn,.... las cabras y las ovejas: beeee, beeee, beeee,) y se pusieron a comer.

Por último acudió corriendo su caballo (tocotoc, tocotoc, tocotoc,..) y también los conejos, porque ellos también querían comer. Y cuando les dio la comida, (movimiento de labios cerrados, abiertos, lento, y algo más rápidos), y allí se quedaron todos.

El granjero, cuando acabó la tarea, se fue a su casa a comer y a descansar un poco.

Cuando llegó la tarde fue al campo con su perro, los dos iban muy alegres; el granjero cantando (lalala lá, lalala lala lala la,....) y el perro lo acompañaba (guauu, guauu, guau guau guauuu,...).

Iban alegres porque tenían que cortar hierba para que los animales de la granja, tuvieran comida al día siguiente.

Cuando acabaron volvieron a la granja igual de contentos (repetir lo anterior, si se quiere con otros ritmos).

Al final del día se fueron a cenar, y después a dormir

(Inspirar por la nariz y echar el aire por la boca, como haciendo el dormido).

Todos los animales de la granja, también dormían felices, porque tenían un granjero que los cuidaba muy bien, y por eso lo querían mucho.

Por eso, siempre que se cuida bien a los animales, nos querrán mucho.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Colorín, colorado,....

1. ¿Que animales están presente en el cuento?
2. ¿Cómo comía el granjero?
3. ¿Cómo hacia la vaca y el pato?
4. ¿Con que animal fue el granjero al campo? ¿Cómo cantaban?
5. Te gusto el cuento

Nota: Se les puede agregar las preguntas que deseen en relación con el tema y trastorno que van a trabajar.

Anexo # 10

Guía de consulta a especialistas

Estimado compañero/a: esta consulta tiene como objetivo realizar una valoración preliminar de la propuesta diseñada luego de la incorporación de las sugerencias dadas para su posterior aplicación en la práctica educativa

Datos generales:

___ Logopeda ___ Profesor de la UCP ___ Maestra ___ Psicopedagoga

___ Médico ___ Otros

Años en la labor que desempeña: _____

Años de experiencia en el nivel donde labora: _____

Licenciado: _____

Categoría Científica: _____

Categoría Docente: _____

1- Marque con una (X) según su opinión respecto al conjunto de actividades para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros.

Muy adecuado (MA)

Poco adecuado (PA)

Adecuado (A)

No es adecuado (NA)

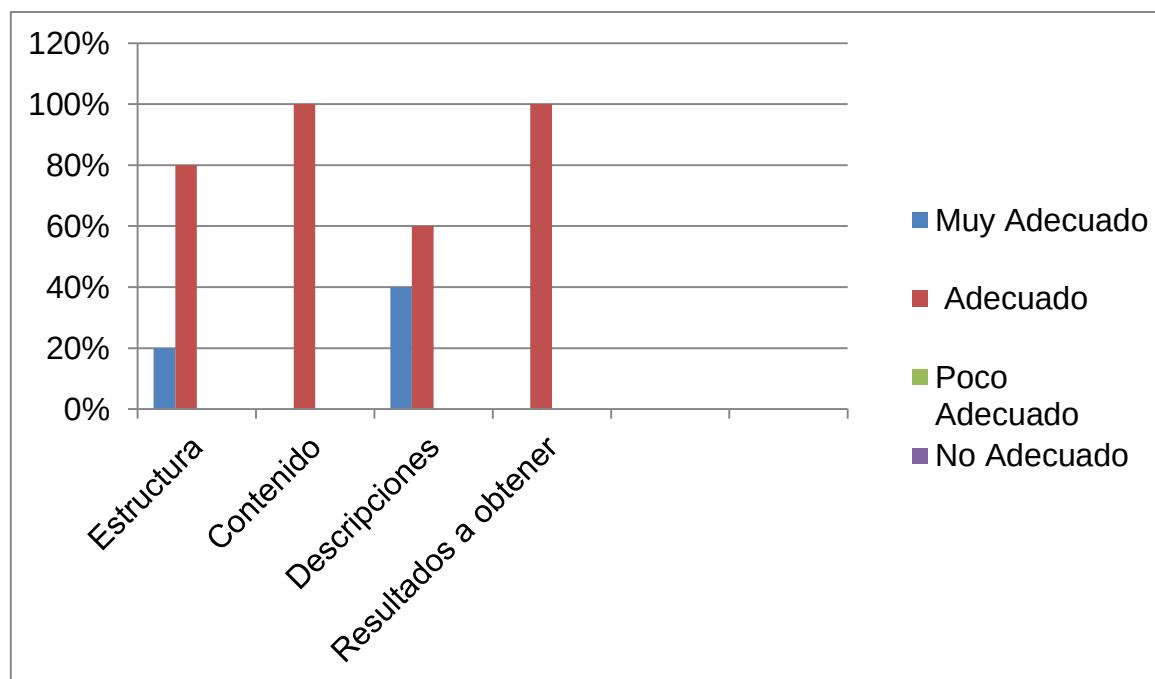
Aspectos a evaluar	MA	A	PA	NA
1- Estructura de las actividades				
2- El contenido de las actividades				
3- Descripción de las actividades				
4- Resultado que se espera obtener con la propuesta diseñada				

Figura: 3 Guía para la consulta a especialistas

2- Sugerencias.

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Gráfico 6.1: Resultado de la consulta a especialistas



La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

ANEXO 11

Criterio de Usuario

Nombre y apellidos:

Ocupación:

Institución, organización o empleo que realiza en la comunidad a la que pertenece:

Estimado colega:

Es nuestro interés someter a su valoración las actividades comunitarias para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros y para lo cual necesitamos de su colaboración para que evalúe las acciones que se ejecutaron en la comunidad y a la cual usted participó para el mejoramiento de las mismas.

Marca con una (x) según su opinión respecto al sistema de actividades.

5- Muy adecuada 4- adecuada 3- Relativamente adecuada

2- poco adecuada 1- no adecuada

Aspectos a evaluar del sistema de actividades comunitarias.	5	4	3	2	1
Las actividades realizadas han sido suficiente, oportunas, satisfactorias, inclusivas, y diferentes.	8 (80%)	2 (20%)			
Las actividades o acciones que se realizaron en la comunidad garantizan la prevención del lenguaje en los niños prematuros.	9 (90%)	1 (10%)			

La atención logopédica comunitaria para la prevención de los trastornos del lenguaje en niños prematuros

Las familias han participado favorablemente en las actividades que se programaron para prevenir del lenguaje en los niños prematuros de su comunidad.	9 (90%)	1 (10%)			
Las familias y los agentes y agencias sociales y educativas realizan las actividades en el hogar para potenciar la prevención de los trastornos del lenguaje en los niños prematuros	10 (100%)				

Figura 4: Criterios de usuarios